# Resumen semanal del 26 al 31 de octubre de 2026: atención psicológica en la universidad, consulta pública sobre salud mental, guía de la OMS y evidencia sobre soledad y TCC escolar

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2026

## Resumen rápido del día

El Real Decreto 855/2026 aprueba el Estatuto del Estudiantado Universitario, en vigor desde el 23 de octubre, y obliga a las universidades a garantizar atención psicológica y de salud mental gratuita y accesible. El Ministerio de Sanidad ha abierto una consulta pública previa para desarrollar el artículo 13 bis de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad; las aportaciones se admiten hasta el 6 de noviembre de 2026. La OMS ha publicado una guía práctica para desinstitucionalizar hospitales psiquiátricos, y la Plataforma Control Z ha presentado un decálogo preventivo sobre pantallas y reclama un Pacto de Estado. Un metaanálisis de 280 estudios en American Psychologist indica que las intervenciones psicológicas son las más prometedoras para reducir la soledad, aunque con certeza de evidencia baja o muy baja, y un ensayo aleatorizado en JAMA Network Open, con 1.793 estudiantes alemanes, indica que la TCC en el aula mejora más que la alfabetización mediática en adolescentes de alto riesgo.

## Noticias nacionales

NORMATIVA · NACIONAL

## El Real Decreto 855/2026 obliga a las universidades a garantizar atención psicológica y de salud mental gratuita al estudiantado

El Real Decreto 855/2026, de 21 de octubre, aprueba el Estatuto del Estudiantado Universitario, publicado en el BOE (BOE-A-2026-21955) y en vigor desde el 23 de octubre de 2026. La norma desarrolla la Ley Orgánica 2/2023 y sustituye al Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre. Según informa Infocop, el texto obliga a las universidades a garantizar al estudiantado el acceso gratuito a orientación y atención psicológica y de salud mental, prestada por personal experto y coordinada con los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas (art. 6.1.e). Además, las universidades deberán disponer de unidades específicas de atención psicológica y salud mental, cuya organización se fijará en los estatutos o en las normas de organización y funcionamiento de cada una (art. 10.5), y derivar al estudiante a los servicios sanitarios autonómicos cuando la situación lo requiera (art. 62.3.g). El Estatuto también exige contar con protocolos de prevención, actuación e intervención ante la conducta suicida (art. 10.6) y con protocolos frente al acoso y ciberacoso sexual, por razón de sexo, orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales, así como frente al acoso personal (arts. 10.7 y 10.8). Las universidades disponen de seis meses para aprobar y poner en funcionamiento los protocolos de conducta suicida, acoso y ciberacoso si aún no existen, y de doce meses para adaptar su normativa y establecer o ajustar las unidades y servicios de atención al estudiantado, incluidos los de atención psicológica y de salud mental. La concreción de cada servicio dependerá de los estatutos y de las normas de cada universidad.

Fuente: Infocop

NORMATIVA · NACIONAL

## Sanidad abre una consulta pública para desarrollar las garantías en salud mental de la Ley de Discapacidad

El Ministerio de Sanidad, a través del Comisionado de Salud Mental, ha abierto una consulta pública previa para desarrollar por reglamento el artículo 13 bis del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013). Ese

artículo se incorporó mediante la Ley 4/2026, de 1 de octubre, publicada en el BOE el 3 de octubre de 2026, y regula la atención integral y comunitaria en salud mental. El documento de la consulta lleva fecha del 21 de octubre de 2026 e identifica cuatro asuntos que necesitan concreción para su aplicación práctica: el consentimiento informado, los apoyos para la toma de decisiones, las actuaciones en situaciones de urgencia y el uso excepcional de contenciones. Según el propio texto, sin desarrollo podrían darse interpretaciones dispares y dificultades para aplicar las garantías. Los objetivos declarados son facilitar la comprensión y aplicación del artículo, dar seguridad jurídica a los profesionales y asegurar que las garantías funcionen de forma efectiva en la atención sanitaria y asistencial. El Ministerio indica que descartó como única respuesta las guías, recomendaciones y manuales por su escasa eficacia jurídica, y que consideró la vía reglamentaria la más adecuada. Las aportaciones pueden enviarse hasta el 6 de noviembre de 2026, inclusive, a comsaludmental@sanidad.gob.es, y solo se tendrán en cuenta las de quienes se identifiquen. Infocop difundió la convocatoria el 28 de octubre. Se trata de la fase previa de consulta: las fuentes consultadas no recogen todavía un texto de reglamento.

Fuente: Ministerio de Sanidad (consulta pública previa de 21 de octubre de 2026) y BOE (Ley 4/2026); difundida por Infocop

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

## La Plataforma Control Z presenta un decálogo para proteger a la infancia y la adolescencia en el entorno digital

La Plataforma Control Z presentó el 27 de octubre de 2026, en la sede de Ecologistas en Acción en Madrid, un decálogo de recomendaciones para proteger a la infancia y la adolescencia frente a los riesgos del entorno digital, según informa Infocop. En el acto intervino José Antonio Luengo, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología y miembro del grupo gestor de la plataforma. Control Z reúne a más de quince organizaciones, entre ellas el COP, sociedades científicas, entidades sanitarias, fundaciones, asociaciones civiles y medios de comunicación, y el decálogo cuenta con el aval unánime de las 14 sociedades médicas y de psicología que la integran. Entre las recomendaciones preventivas figuran evitar las pantallas de 0 a 6

años, salvo usos sociales puntuales y supervisados como las videollamadas familiares; una exposición progresiva, acompañada y con límites de 7 a 16 años, con menos de 1 hora diaria entre 7 y 12 años y menos de 2 horas entre 13 y 16 años, incluido el tiempo escolar y los deberes; y retrasar hasta los 16 años la entrega de un smartphone personal con acceso libre a Internet. También se propone reforzar la prevención y la detección temprana de problemas de salud mental en los centros educativos, formar al profesorado y exigir responsabilidad a las empresas tecnológicas. El documento advierte de que las asociaciones observadas entre el uso de tecnologías y los problemas de salud no implican necesariamente causalidad, y de que los límites de edad y tiempo son recomendaciones preventivas, no umbrales biológicos demostrados. Cita datos del informe PISA 2025: el 29 % del alumnado español indica que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales en la mayoría o la totalidad de las clases de ciencias, frente al 28 % de la media de la OCDE, sin que los datos permitan atribuir una relación causal con el rendimiento. La plataforma reclama un Pacto de Estado y, una vez constituido el nuevo gobierno, solicitará reuniones con los ministerios competentes en infancia, juventud y educación.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

## Noticias internacionales

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

### La OMS publica una guía práctica para la transición hacia una atención comunitaria en salud mental

La Organización Mundial de la Salud ha publicado la guía práctica «Supporting the transition to community-based mental health and social care» (Apoyo a la transición hacia la atención en salud mental y social de base comunitaria), con fecha de 9 de octubre de 2026. Va dirigida sobre todo a responsables de hospitales psiquiátricos y a autoridades sanitarias, y tiene como objetivo promover la desinstitucionalización de adultos que han pasado largos periodos ingresados, en especial estancias de seis meses o más. Según la OMS, la atención institucional sigue siendo dominante, consume gran parte de los recursos de salud mental, aleja a las personas de sus comunidades, limita su

autonomía y aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos. La guía plantea que la desinstitucionalización exige una reforma de todo el sistema, que alinee políticas, leyes y financiación, desarrolle servicios comunitarios y apoyos de vivienda y cambie las prácticas y la cultura de atención. Propone actuar en tres fases (planificar, preparar y prestar servicios). Según la reseña de Infocop, la guía recomienda equipos multidisciplinares con psicología, psiquiatría, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional y personas con experiencia vivida, y advierte de que cerrar hospitales o dar altas no basta. Infocop recoge además datos del Atlas de Salud Mental de la OMS 2024 citados en la guía: el 81 % de los países que informan siguen prestando servicios en hospitales psiquiátricos, el 47 % del gasto en salud mental se destina a ellos (datos de 49 países), el 28 % de las personas ingresadas permanece más de seis meses y el 16 % más de un año. De los 138 países analizados, el 9 % ha completado la transición, el 53 % está en fases iniciales y el 20 % no la ha iniciado.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

## Las intervenciones psicológicas son las más prometedoras contra la soledad, según un metaanálisis de 280 estudios

Un metaanálisis publicado en American Psychologist, reseñado por Infocop y por la nota de prensa de la APA, revisa 280 estudios sobre intervenciones para reducir la soledad. Partió de 312 estudios identificados y, según Infocop, incluye 146 ensayos clínicos aleatorizados, 40 estudios multicohorte con grupo de comparación y 126 estudios de un solo grupo. La nota de la APA cifra en más de 30.000 las personas participantes en todo el mundo. Más de la mitad de los trabajos se publicaron entre 2020 y 2024, y el 54 % se centró en personas de 65 años o más. Las intervenciones se agruparon en cinco categorías: psicológicas, entrenamiento en habilidades sociales y emocionales, ampliación de redes sociales, apoyo social y psicoeducación. Todas redujeron la soledad a corto plazo, con efectos pequeños o moderados, y los beneficios se mantuvieron entre uno y seis meses. Las intervenciones psicológicas mostraron el efecto más fuerte, moderado y en algunos análisis elevado, apoyado en 48 ensayos clínicos aleatorizados; los programas solo digitales

resultaron menos eficaces que los presenciales, según la APA. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas por grupos de edad. Los autores califican la certeza de la evidencia como baja o muy baja por la aleatorización poco clara, las muestras pequeñas, las pérdidas de seguimiento y el reclutamiento no dirigido a personas con soledad.

Fuente: Infocop y American Psychological Association

## Publicaciones científicas recientes

Glynn, L. M., Liu, S. R., Golden, C., Weiss, M., Taylor Lucas, C., Cooper, D. M., Ehwerhemuepha, L., Stern, H. S., y Baram, T. Z. (2026). Unpredictability is a childhood adversity that contributes to mental health problems. Nature Mental Health, 4(8), 1219-1226. https://doi.org/10.1038/s44220-026-00681-x

DOI: 10.1038/s44220-026-00681-x

**Hallazgo:** Con 29.861 menores de 0 a 17 años de 19 clínicas pediátricas de California, el estudio comparó el cuestionario PEARLS de experiencias adversas con el QUIC-5 de imprevisibilidad y los cruzó con los diagnósticos de las historias clínicas. Ambos instrumentos se asociaron de forma gradual con depresión, ansiedad, problemas de conducta, trastornos del sueño, dolor abdominal y cefaleas. El QUIC-5 aportó información adicional y, usados juntos, mejoraron la capacidad predictiva. Los menores con puntuación máxima en QUIC-5 y sin experiencias adversas en PEARLS tenían 11,7 veces más probabilidad de diagnóstico de depresión que quienes no puntuaban en ninguno.

**Implicación clínica:** Los resultados sugieren que medir la imprevisibilidad puede complementar el cribado de adversidad infantil y orientar la detección de menores vulnerables. Al tratarse de un diseño transversal, no permiten establecer causalidad ni evalúan la eficacia de ninguna intervención.

## Herramientas clínicas e instrumentos

– **Prueba de cognición social con película para adultos hispanohablantes:** El número 4 del volumen 38 de Psicothema, publicado el 19 de octubre de 2026, incluye un estudio de Llompart-Casasnovas y colaboradores sobre la evaluación psicométrica y un marco normativo de una película para evaluar cognición social en adultos hispanohablantes (MASC-SP). Infocop solo recoge el título y el objetivo, sin resultados.

– **Protocolo para desarrollar estudios de validación de instrumentos:** El mismo número de Psicothema incluye el protocolo PROVAL, de Benítez, González-Gómez y Padilla, que propone una guía integral para desarrollar estudios de validación de instrumentos psicológicos. Puede resultar de interés para quien trabaje con adaptación y baremación de pruebas.

## Prioridades del día

### Seguir cómo desarrollan las universidades la atención psicológica al estudiantado

Puede ser relevante estar atentos a cómo concretan las universidades, en sus estatutos o normas, las unidades y servicios de atención psicológica y de salud mental que prevé el Real Decreto 855/2026, ya que la organización de esas unidades se fijará en cada universidad y los plazos previstos son de seis y doce meses.

### Valorar si enviar aportaciones a la consulta pública antes del 6 de noviembre

Puede ser oportuno que profesionales, colegios y divisiones exploren si desean enviar aportaciones a la consulta pública previa sobre el artículo 13 bis, que se recibe por correo electrónico hasta el 6 de noviembre de 2026 y en la que solo se consideran las de remitentes identificados. Es una fase previa y todavía no hay texto del reglamento.

### Mantener una lectura prudente de la evidencia sobre soledad y TCC escolar

Puede ser útil recordar que el metaanálisis sobre soledad señala certeza de evidencia baja o muy baja, y que la mejoría de la TCC escolar se describe en los estudiantes de alto riesgo y no en la muestra total, de modo que los resultados sugieren líneas de trabajo y no conclusiones definitivas.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — domingo 1 de noviembre de 2026